

# Resumen de la agenda de investigación y acción: Pueblos Indígenas

## Resumen Ejecutivo

Connecting Climate Minds (CCM) es una iniciativa financiada por Wellcome que tiene como objetivo cultivar una colaboración trans-disciplinaria de cambio climático y del área de salud mental con una visión clara y alineada. A lo largo del último año, hemos reunido a expertos de distintas disciplinas, sectores y países para desarrollar agendas de investigación y acción regionales, temáticas y globales. Estas agendas exponen 1) prioridades de investigación prioritarias para comprender y abordar las necesidades de las personas que experimentan la carga de salud mental de la crisis climática, y 2) prioridades para permitir esta investigación y convertir la evidencia en acción política y práctica. Este informe resume la agenda de investigación y acción sobre cambio climático y salud mental para los pueblos indígenas; la agenda completa<sup>1</sup> se ha publicado por separado y está disponible [aquí](#).

Las comunidades indígenas se enfrentan a innumerables desafíos derivados del cambio climático que afectan considerablemente a su salud mental y que se ven agravados sistemáticamente por historias de colonización y opresión estructural. Algunos de los desafíos más significativos que surgieron en los diálogos del CCM y que son causas y consecuencias de la crisis climática incluyen los impactos perjudiciales del extractivismo, las luchas por los derechos a la tierra y la falta de soberanía territorial, que intensifican la desconexión con la tierra y la vulnerabilidad colectiva ante pérdidas y daños. El acceso limitado al agua potable, las alteraciones de la soberanía alimentaria y los desplazamientos y migraciones forzados (impulsados por problemas relacionados con el cambio climático, las industrias extractivas y los proyectos de desarrollo) amplifican los problemas de salud mental y bienestar en estas

comunidades y alteran las prácticas tradicionales que confieren resiliencia ecológica y psicológica. Además, el impacto del cambio climático en las prácticas culturales, unido a la profanación y pérdida de lugares sagrados, se traduce en una profunda pérdida de identidad cultural. En la raíz de todos estos retos se encuentran herencias coloniales profundamente arraigadas, unidas a las drásticas transformaciones medioambientales contemporáneas, que agravan los complejos problemas a los que se enfrentan las poblaciones indígenas.

Ciertos subgrupos de las comunidades indígenas, como los ancianos, los defensores del medio ambiente, las viudas, los menores, las personas con problemas de salud, los desplazados que viven en asentamientos temporales, los discapacitados y los que residen en reservas, afrontan problemas desproporcionados relacionados con la salud mental y el cambio climático.

Para fomentar unas relaciones apropiadas<sup>2</sup> con el medio ambiente y promover la sanación tanto de las personas como de la tierra, es imperativo que los investigadores, los responsables políticos y los profesionales adopten marcos que se ajusten a las cosmovisiones indígenas. La investigación, las políticas, los programas y las prácticas que reconocen y apoyan la importancia de las prácticas culturales y la transmisión dinámica ( comunicación bidireccional y retroalimentación entre las cosmovisiones indígenas y la biomedicina occidental que ayuda a encontrar un terreno común ) pueden contribuir a crear y mantener conexiones positivas entre las comunidades indígenas y su entorno. Este enfoque no sólo favorece la salud mental, sino que también contribuye al bienestar general tanto de las personas como del planeta.

A partir de nuestro diálogo con representantes de grupos indígenas, esta agenda propone 23 temas prioritarios de investigación que abarcan una mirada de áreas, entre ellas:

- Comprender los efectos en la salud mental de las alteraciones relacionadas con el clima en las prácticas tradicionales, los rituales, los lugares sagrados y las conexiones espirituales con la tierra
- Explorar cómo diversos factores, como el trauma intergeneracional derivado de la violencia colonial y el estrés agravado por las crisis relacionadas con el clima, pueden intensificar los efectos del cambio climático en la salud mental
- Explorar cómo integrar enfoques ancestrales y de medicina tradicional en intervenciones de salud climatológica co-creadas y culturalmente apropiadas

- Comprender el impacto de la soberanía territorial en la salud mental en el contexto del cambio climático
- Comprender los obstáculos que dificultan el apoyo a la salud mental en relación con el clima, en particular para los pueblos indígenas de zonas remotas/rurales

El equipo de investigación, con la orientación del Grupo Asesor Indígena [Indigenous Advisory Group], ha tenido presente la no homogeneidad y el reconocimiento de la gran diversidad de perspectivas y experiencias de los pueblos indígenas de todo el mundo. Aunque las lecciones y los hallazgos clave son importantes, el aspecto más sustancial de este trabajo está relacionado con el proceso de compromiso con los colaboradores indígenas. La investigación futura en este campo puede beneficiarse de las lecciones aprendidas sobre la colaboración en la investigación y la aplicación de procesos que apoyen las relaciones apropiadas, la soberanía indígena y la propiedad del conocimiento. Entre las principales enseñanzas extraídas de este trabajo cabe citar la adaptación de los protocolos de consentimiento informado a la soberanía indígena, la facilitación del acceso a los participantes de habla no inglesa y la priorización de las concepciones indígenas de la salud mental y el cambio climático, por ejemplo mediante el uso de las lentes del bienestar ecológico y las relaciones de parentesco frente a las concepciones biomédicas occidentales. Programas como el nuestro son un paso hacia la creación de conexiones entre diferentes formas de saber y hacer. Esto es vital para ayudar a apoyar y defender la integración de estos enfoques en una acción más amplia sobre el clima y la salud mental.

# Introducción

## Incorporar la salud mental de los Pueblos Indígenas

Este documento pretende abarcar las perspectivas colectivas y relacionales de los pueblos indígenas sobre la salud mental y el bienestar, reconociendo la conexión inseparable entre el bienestar humano y la tierra, con el fin de conceptualizar mejor las implicaciones del cambio climático para la salud.<sup>3, 4</sup> Para comprenderlas es necesario reconocer las intrincadas relaciones que se entretajan en las experiencias vividas por los indígenas, desafiando las divisiones categóricas convencionales de las percepciones que no logran encapsular la naturaleza *interconectada e interdependiente* de las perspectivas indígenas sobre la salud mental y el medio ambiente. Adoptar una visión holística es esencial, ya que estos hallazgos subrayan el tapiz profundamente entretornado de tipos de bienestar<sup>5</sup> (por ejemplo, emocional, espiritual, psicológico, social, cultural, ecológico), desafiando las divisiones nítidas y haciendo énfasis en el entrelazamiento intrínseco de todos los aspectos de la experiencia vivida por los indígenas. En el apéndice se ofrece más información sobre el contexto en el que se enmarcan estos conceptos y la interpretación de los términos clave.

## Cambio climático y salud mental de los Pueblos Indígenas

### Investigación existente

En 2010, un informe de las Naciones Unidas concluía que "los pueblos indígenas con estrechos vínculos emocionales y ancestrales con la tierra también son susceptibles de verse desproporcionadamente afectados por el cambio ambiental y los fenómenos meteorológicos extremos".<sup>6</sup> En la última década, la intensificación de los fenómenos relacionados con el clima, tal como incendios forestales, inundaciones y sequías, ha magnificado las amenazas a los medios de subsistencia, las prácticas culturales y el bienestar general de los indígenas, especialmente entre quienes viven en primera línea del cambio climático.<sup>7</sup> Los investigadores y profesionales de la salud mental, así como los propios pueblos indígenas, reconocen los legados socio-psicológicos de la colonización.<sup>8</sup> Las comunidades indígenas siguen sufriendo sistemas de desigualdad y marginación, y se enfrentan a violaciones generalizadas de los derechos humanos y al despojo de sus tierras en todo el mundo.<sup>9,10</sup> Los traumas históricos se intensifican aún más por las amenazas del cambio climático que alteran activamente los factores determinantes de la salud y el bienestar mental de los pueblos

indígenas, como las relaciones con el lugar, los medios de subsistencia y la identidad cultural.<sup>11,12</sup> Los nuevos desafíos incluyen el duelo y la ansiedad ecológicos,<sup>13</sup> las experiencias de solastalgia debidas a la pérdida de lugares preciados<sup>14</sup> y la lucha contra las consecuencias intangibles de la pérdida y el daño ambientales.

A pesar de la enorme carga que el cambio climático y las opresiones estructurales suponen para la salud mental y el bienestar de los indígenas, aún no se ha investigado lo suficiente sobre las repercusiones específicas del cambio climático en la salud mental de las comunidades indígenas de diversas zonas geográficas. Una de las dimensiones de esta falta de datos es que muchas lenguas indígenas carecen de un vocabulario específico para referirse a afecciones como la depresión o las enfermedades mentales,<sup>15</sup> lo que hace que la investigación no refleje adecuadamente la realidad vivida por estas comunidades. Tanto o más desapercibidos son los contextos y concepciones culturalmente relevantes de la "salud mental" y el marco más amplio de la salud y el bienestar en las poblaciones indígenas.

Los servicios de salud mental públicos y generales suelen pasar por alto los marcos de salud indígenas, lo que limita su capacidad para atender plenamente las necesidades de curación de las personas, especialmente las que no pertenecen a contextos occidentales, de clase media, blancos, urbanos e industrializados, ni a entornos terapéuticos occidentales. Cada vez hay más pruebas en torno a la lógica terapéutica de las Primeras Naciones [First Nations] que demuestran el importante impacto positivo de la participación en prácticas culturales tradicionales como tratamiento del malestar psicosocial<sup>16</sup>, así como el fomento de fuertes conexiones con la tierra y el país<sup>17, 18</sup> — ambas especialmente relevantes en el contexto de las pérdidas y daños relacionados con el clima.

A medida que se amplía la investigación sobre la intersección entre el cambio climático y la salud mental, es imperativo que los investigadores y profesionales no indígenas se inspiren y se guíen por lo que muchos estudiantes y comunidades indígenas han estado defendiendo: "Nada sobre nosotros sin nosotros."<sup>19</sup>

## Hallazgos del proyecto Connecting Climate Minds

La siguiente sección establece el contexto de la investigación realizada con los pueblos indígenas como parte del proyecto Connecting Climate Minds (CCM), presentando una síntesis de lo que escuchamos a través del diálogo, las consultas a expertos y una revisión de

la literatura como necesidades emergentes clave de estos grupos para la salud mental en el contexto del cambio climático.

### **¿Qué resultados de salud mental parecen verse afectados?**

En consonancia con la conceptualización de la salud mental en las comunidades indígenas ( representada aquí como una experiencia polifacética de bienestar que abarca aspectos emocionales, relacionales, culturales y espirituales interconectados ) , esta agenda incluye experiencias relatadas que pueden solaparse con síntomas de problemas de salud mental tal como se definen en el proyecto CCM más amplio o con aspectos más amplios de bienestar.

Entre las consecuencias notificadas figuran el duelo ecológico y la ansiedad, la solastalgia, el aumento del estrés, la fatiga, una sensación de desilusión sobre el futuro y el aumento de las tasas de adicción y suicidio.

### **¿Quiénes parecen ser particularmente afectados por los impactos del cambio climático en la salud mental?**

Se identificaron los siguientes subgrupos de población como especialmente vulnerables a las repercusiones del cambio climático en la salud mental – y en general:

- Menores
- Comunidades que viven en zonas costeras y ríos
- Miembros de la comunidad con enfermedades preexistentes
- Desplazados y personas que viven en asentamientos provisionales
- Ancianos
- Defensores del medio ambiente y de la tierra
- Comunidades pastorales
- Personas que viven en reservas indígenas
- Personas con movilidad limitada
- Viudas

## ¿Cuáles parecen ser las vías y mecanismos que vinculan estos peligros climáticos con los resultados de la salud mental?

- Dolor y trauma agravados por la exposición a múltiples/repetidas catástrofes relacionadas con el clima
- Alteraciones culturales inducidas por el clima, como la desconexión de la tierra y la alteración de ceremonias y prácticas curativas
- La salud del territorio como factor determinante de la salud mental indígena
- Pérdida de la seguridad alimentaria y de los medios de subsistencia económicos
- Interrupciones relacionadas con el agua
- Migración y desplazamiento sistémicos inducidos por el clima

## Agenda de investigación

### Temas de investigación prioritarios

Esta agenda de investigación presenta una visión alineada para guiar el campo del clima y la salud mental de los pueblos indígenas. Los temas de investigación prioritarios que se enumeran más abajo se han desarrollado a través de un amplio proceso consultivo; se presentan dentro de cuatro categorías generales de investigación que se identificaron como áreas de necesidad crítica para seguir trabajando a nivel mundial, sobre la base de una revisión inicial de la literatura (véase el apéndice para más detalles). Los temas de investigación prioritarios representan áreas donde la inversión en investigación específica podría crear una imagen completa de los impactos relacionados con el clima en los desafíos de salud mental, sus mecanismos y soluciones en las acciones climáticas y de salud mental.

El equipo de investigación hizo un esfuerzo intencionado para que los temas incluyeran las concepciones indígenas de estas cuestiones, por lo que se incluyeron términos relacionados con el bienestar. La elección de salud mental frente a bienestar mental en los siguientes temas se basa en los términos o planteamientos específicos utilizados por los participantes en el diálogo en los debates pertinentes que, en última instancia, llevaron a la elaboración de ese tema. Los investigadores deben tener en cuenta la selección de resultados y medidas apropiados en los que centrarse para cada tema de investigación, basándose en un profundo conocimiento de lo que es relevante para las comunidades indígenas con las que trabajan.

| Categoría de investigación                       | Temas de investigación prioritarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Impactos, riesgos y grupos vulnerables</b> | Comprender cómo se manifiesta el trauma intergeneracional resultante de la violencia colonial en las comunidades/grupos indígenas (incluyendo los impactos en la salud mental, las prácticas culturales y la cohesión social a través de generaciones sucesivas) y por qué esta comprensión es vital para comprender las intersecciones entre el clima y la salud mental para estas comunidades. |
|                                                  | Comprender en qué medida las experiencias continuas y agravadas de la crisis climática causan estrés/duelo en los pueblos indígenas y en qué momento estas experiencias se vuelven debilitantes y repercuten en el funcionamiento personal y social hasta el punto de constituir un problema de salud mental.                                                                                    |
|                                                  | Identificar los riesgos, desencadenantes y factores de estrés específicos relacionados con el clima que aumentan la carga de salud mental de los subgrupos indígenas especialmente vulnerables.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  | Comprender cómo los esfuerzos de investigación centrados en los impactos del cambio climático sobre la salud mental entre las poblaciones indígenas pueden implicarse y contribuir a esfuerzos decoloniales y basados en los derechos más amplios.                                                                                                                                               |
| <b>II. Vías y mecanismos</b>                     | Comprender cómo los cambios relacionados con el clima, como la alteración de las estaciones o los fenómenos meteorológicos extremos, afectan a las ceremonias tradicionales, las prácticas espirituales y los lugares sagrados, y cómo esto repercute en la salud mental y el bienestar de las comunidades indígenas.                                                                            |
|                                                  | Comprender cómo la preservación de prácticas tradicionales, rituales, lugares sagrados y conexiones espirituales con la tierra contribuye al mantenimiento de la continuidad cultural y la resiliencia de la salud mental entre las comunidades indígenas que se enfrentan a la degradación climática.                                                                                           |
|                                                  | Comprender las formas en que las poblaciones indígenas conceptualizan la interdependencia del bienestar humano con el mundo natural a través de conexiones espirituales, y cómo esas conceptualizaciones repercuten en la                                                                                                                                                                        |

salud mental en medio del cambio climático.

Identificar las políticas y acciones gubernamentales más eficaces para salvaguardar las tierras y la salud de los pueblos indígenas en el contexto de la crisis climática y explorar qué mecanismos institucionales garantizan que estas políticas se ajustan a las normas y marcos jurídicos internacionales.

Comprender cómo el reconocimiento de la conexión inseparable entre la vitalidad de la tierra, el agua y la salud de las comunidades indígenas repercute en la salud mental y el bienestar individuales y colectivos de estas comunidades. Identificar las prácticas y creencias culturales específicas que refuerzan esta relación simbiótica y contribuyen al florecimiento de los ecosistemas y las personas.

Explorar las ramificaciones en la salud mental de las amenazas relacionadas con el clima para los modos de vida tradicionales y la soberanía alimentaria.

Comprender cómo los efectos culturales, económicos y de bienestar mental de los problemas relacionados con el agua afectan a los medios de subsistencia y a la capacidad de adaptación de las comunidades indígenas.

Comprender cómo el derecho a quedarse o la necesidad de marcharse que experimentan las comunidades indígenas repercute en la salud mental, y cómo los recursos financieros y de apoyo disponibles en esas situaciones (por ejemplo, visados, estatus de refugiado climático, planes de compensación), contribuyen a los resultados climáticos y de salud mental.

Comprender los distintos factores de estrés que experimentan las poblaciones indígenas debido a la ausencia de control sobre sus territorios tradicionales y a su limitado autogobierno en el contexto del cambio climático, y cómo estos factores de estrés repercuten en su salud mental y su bienestar.

Identificar los mecanismos más eficaces de intercambio de conocimientos y apoyo mutuo para fomentar el bienestar y la resiliencia de la salud mental de las poblaciones indígenas en el contexto del cambio climático.

Comprender cómo la escasez de recursos de salud mental y la falta de mecanismos de comunicación y apoyo para los asentamientos rurales/remotos contribuyen a los desafíos de abordar las necesidades únicas

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | de salud mental relacionadas con el clima dentro de las comunidades indígenas, e identificar las barreras específicas que dificultan la accesibilidad a los servicios y cómo éstas pueden empeorar en la crisis climática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>III. Beneficios para la salud mental de la acción climática</b>                        | Comprender cómo adaptar la política de salud mental y las intervenciones comunitarias para promover la sostenibilidad ecológica y el bienestar mental entre las poblaciones indígenas, fomentando una fuerte conexión con la tierra y el país.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                           | Comprender cómo iniciativas como el rescate de semillas y el cultivo de huertos domésticos contribuyen a la resiliencia climática y a la preservación de la identidad cultural dentro de las comunidades indígenas y cómo esto repercute en el bienestar social, económico y mental de las personas y las comunidades.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | Explorar las formas en que la recuperación y revitalización de las prácticas ancestrales por parte de los jóvenes y ancianos indígenas en medio de la destrucción de la tierra y el patrimonio cultural 1) ofrece oportunidades para la curación de los individuos y el medio ambiente, 2) contribuye a un sentido de empoderamiento y autonomía dentro de las comunidades indígenas, y 3) repercute en los resultados de salud mental.                                                                                    |
|                                                                                           | Explorar cómo amplificar y dotar de recursos las intervenciones dirigidas por indígenas en la acción climática que apoyen los resultados de salud mental para esas comunidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IV. Intervenciones/ soluciones de salud mental en el contexto del cambio climático</b> | Evaluar cómo la soberanía territorial en el contexto del cambio climático para las poblaciones indígenas es una intervención de salud mental en sí misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           | Reconocer, evaluar e integrar los enfoques ancestrales y de medicina tradicional en la investigación sobre el cambio climático y la salud mental con el fin de identificar y desarrollar intervenciones eficaces y culturalmente apropiadas para los problemas de salud mental relacionados con el clima. Esto incluye integrar los enfoques medicinales y/o las prácticas curativas más eficaces para ayudar a los miembros de la comunidad a hacer frente a las consecuencias del cambio climático para la salud mental. |
|                                                                                           | Explorar formas de animar a los curanderos indígenas, los guardianes de la sabiduría tradicional, los líderes comunitarios y los profesionales de la salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

mental a crear conjuntamente intervenciones interculturales de salud mental relacionadas con el clima que aprovechen los puntos fuertes de las prácticas indígenas tradicionales y los enfoques biomédicos contemporáneos, y evaluar la eficacia de estas intervenciones.

Comprender en qué medida las iniciativas de revitalización cultural y las intervenciones dirigidas por la comunidad sirven como amortiguadores eficaces contra los impactos en la salud mental de los traumas intergeneracionales relacionados con la violencia colonial y el cambio climático entre los grupos indígenas, y qué papel desempeñan estas iniciativas en el fomento de la resiliencia y la mejora de la salud mental dentro de las comunidades.

## Agenda de acción

Las prioridades de investigación identificadas sólo tendrán valor si se ponen en práctica. El campo del clima y la salud mental es relativamente nuevo y está creciendo rápidamente, y ahora es el momento de garantizar que está diseñado para ofrecer un futuro mentalmente más saludable en el contexto de la crisis climática.

### Próximos pasos prioritarios/recomendaciones para inversores y participantes

Más abajo se resumen las acciones clave y los próximos pasos prioritarios para poner en práctica la agenda de investigación y trasladar a la política y la práctica las evidencias generadas a través de la investigación.

#### Trabajar por la protección de las prácticas curativas tradicionales y los conocimientos ecológicos tradicionales como patrimonio cultural.

- Abogar por el reconocimiento jurídico y la protección de las prácticas curativas tradicionales y los conocimientos ecológicos tradicionales como parte del patrimonio cultural de las comunidades indígenas, con múltiples beneficios para la salud de las personas y los territorios. Trabajar para incorporar estos aspectos a los marcos jurídicos nacionales e internacionales.

- Establecer colaboraciones entre las comunidades indígenas y las instituciones culturales para ayudar a las comunidades a crear archivos o depósitos comunitarios de prácticas curativas tradicionales y conocimientos ecológicos tradicionales. Estos repositorios deben dar prioridad al control comunitario, la accesibilidad y la capacidad de gestionar y compartir información dentro de la comunidad.
- Desarrollar programas educativos para concienciar sobre la importancia de las prácticas curativas tradicionales y los conocimientos ecológicos tradicionales y sus beneficios colaterales para la salud mental.

### **Invertir en el apoyo a los intercambios de conocimientos entre los ancianos indígenas y los jóvenes.**

- Apoyar activamente los espacios dirigidos por la comunidad para que los Ancianos transmitan los conocimientos curativos tradicionales a las generaciones más jóvenes, fomentando la continuidad y preservando las prácticas culturales que pueden fortalecer la resiliencia climática y la salud mental y el bienestar.
- Trabajar con profesionales de la cultura, artistas y escritores indígenas para crear depósitos vivos de su patrimonio cultural (también digital).

### **Aplicar procedimientos sencillos para acceder a subvenciones y recursos financieros y establecer asociaciones de financiación a largo plazo.**

- Se necesitan recursos para apoyar cualquier acción dirigida por la comunidad, y a menudo están ligados a las agendas de los financiadores. Es necesario ofrecer a las comunidades indígenas programas de subvenciones de fácil acceso, sin burocracia innecesaria ni decisiones de los financiadores sobre el uso de esos fondos. Adoptar un enfoque comunitario que permita a las comunidades indígenas priorizar sus necesidades de financiación.
- Designar representantes indígenas en las agencias u organizaciones de financiación. Estas personas pueden servir como puntos de contacto para las comunidades indígenas, ofreciendo orientación y asistencia personalizadas a lo largo de las fases de solicitud y presentación de informes.
- Establecer asociaciones de financiación a largo plazo con las comunidades indígenas para fomentar la confianza y la continuidad. Los compromisos de financiación

plurianuales pueden reducir la carga de los frecuentes procesos de solicitud y proporcionar estabilidad a las iniciativas comunitarias.

### **Centrar los esfuerzos de investigación en reforzar los servicios públicos interculturales de salud mental.**

- Desarrollar herramientas de evaluación culturalmente informadas que tengan en cuenta las diversas expresiones de la salud mental y el bienestar. Reconocer y guiarse por las concepciones indígenas del bienestar, que difieren de los marcos de diagnóstico occidentales.
- Reforzar los enfoques etnográficos en la investigación sobre salud mental. Además, fomentar más conexiones entre los campos de la antropología médica, la antropología psiquiátrica y la psiquiatría intercultural, y ponerlos en conversación con los climatólogos locales de cada contexto.
- Contratar investigadores que sean miembros de las comunidades indígenas o hablen con fluidez las lenguas que se hablan en ellas.
- Generar más colaboraciones de investigación entre los campos de la salud de la tierra y la salud mental.
- Generar más colaboraciones de investigación a través de las barreras lingüísticas (es decir, investigadores indígenas de habla hispana, francesa e inglesa sobre salud mental y clima) para evitar los aislamientos entre grupos lingüísticos coloniales.

### **Defender y aplicar políticas que apoyen servicios de salud mental culturalmente sensibles.**

- Garantizar que las políticas reflejen las necesidades y derechos específicos de las personas y comunidades indígenas.
- Aplicar enfoques de atención que tengan en cuenta los traumas y que reconozcan y aborden los traumas históricos e intergeneracionales sufridos por las personas y comunidades indígenas.
- Incorporar factores de protección que contribuyan a la salud mental y el bienestar (por ejemplo, acceso a recursos culturales que permitan la continuidad cultural) en los esfuerzos de promoción de la salud mental.
- La representación inadecuada de los pueblos indígenas en la gobernanza sanitaria, la creación de políticas y la prestación de servicios puede obstaculizar el desarrollo de

sistemas sanitarios que tengan en cuenta las diferencias culturales. Trabajar y contratar a trabajadores sanitarios, psicólogos y curanderos tradicionales indígenas.

### **Integrar los conocimientos indígenas en las campañas sobre el clima.**

- La conexión y el parentesco con el mundo no humano y tejido de vida pueden abrir muchos caminos hacia distintas formas de relacionarse con el mundo vivo y de responder a sus drásticos desequilibrios. Centrarse en el vínculo entre la salud planetaria y el bienestar humano.
- Colaborar con las comunidades Indígenas para co-crear e implementar campañas climáticas. Incorporar los conocimientos ecológicos tradicionales a las estrategias y soluciones de las campañas.
- Dar prioridad a la creación de relaciones a largo plazo basadas en el respeto y la confianza mutuos. Comprometerse a colaborar de forma continuada más allá de la duración de campañas concretas.

### **Defender y apoyar activamente la soberanía de las tierras indígenas y la protección de los lugares sagrados.**

- Colaborar con las comunidades indígenas para identificar y salvaguardar las zonas de importancia cultural. Llevar a cabo campañas educativas, talleres y actos para destacar la importancia de la soberanía de las tierras indígenas y la protección de los lugares sagrados. Fomentar una comprensión más amplia del contexto histórico y de las luchas en curso. Fomentar la desinversión en proyectos que atenten contra la soberanía de las tierras indígenas.
- Dar recursos para ayudar a las comunidades indígenas a recomprar sus tierras ancestrales.
- Desarrollar políticas y prácticas que protejan explícitamente los lugares sagrados y garantizar su aplicación por parte de los agentes locales e internacionales (por ejemplo, el sector minero, los sindicatos agrícolas).

# Conclusión

Este programa de investigación y acción no pretende hablar en nombre de los grupos indígenas, ni pretende abarcar un ámbito exhaustivo de sus experiencias vividas y de la relación entre el cambio climático y la salud mental. No se trata de ninguna manera de un programa exhaustivo y debe considerarse como punto de partida para un mayor compromiso y una acción cuidadosa. Los temas de investigación aquí tratados están limitados por la capacidad del equipo para llegar a los distintos grupos y experiencias vividas y por la enorme heterogeneidad de las culturas indígenas en todo el planeta. También están sujetos a la posición de nuestro equipo, las prioridades de nuestros financiadores, los recursos disponibles para encontrar, acceder y compensar a los colaboradores y el tiempo asignado para elaborar el informe.

Aunque este proyecto se encuentra dentro del marco biomédico de la salud mental, la pregunta central de este esfuerzo también es: ¿qué se está borrando si solo hablamos en estos términos? Tal vez los marcos occidentales que limitan la salud mental a modelos biomédicos sean igualmente una reflexión de la separación entre personas y territorios, que es en sí misma un síntoma de un problema subyacente en la raíz de la crisis climática. Si vemos que estas separaciones coloniales están en la raíz del cambio climático y también en la raíz de cómo entendemos la salud mental, tenemos que dejar más espacio para que nuestros cuerpos colectivos de conocimiento pasen a la vanguardia de cómo entendemos y alimentamos el bienestar.

Las orientaciones para el aprendizaje y la acción identificadas en este programa requieren contextualización a nivel local, regional y global. Los pasos de investigación y acción descritos anteriormente constituyen un punto de partida para toda una serie de partes interesadas. Las lecciones claves del proceso documentadas, como aquellas relacionadas con el fomento de la confianza, el trabajo de manera colaborativa y el respeto de la soberanía indígena, pueden aplicarse a múltiples contextos de investigación y acción. Invitamos a otros a participar en una investigación sensible, respetuosa y basada en la comunidad, enraizada en la autodeterminación y la determinación colectiva. Los esfuerzos colectivos para afrontar y responder a la crisis climática deben seguir centrados en la defensa y la mejora de los conocimientos indígenas relacionados con la salud mental y el cambio climático.

# Quién elaboró este informe

## Equipo de redacción

**Jefes de Proyecto:** María Faciolince Martina y Lian Zeitz

### Asesores de Proyecto:

- Kisani Upward, Candidata al PhD/Investigadora en salud aborigen de la Universidad de Nueva Inglaterra.
- Dr. Allison Kelliher, MD Johns Hopkins
- Dr. Donald Warne, MD, MPH, Johns Hopkins
- Dr. Kenneth Yongabi Anchang, PhD, Universidad Estatal de Imo
- Faris Ridzuan, Becario tutor de posgrado, Universidad Nacional de Singapur
- Dr. Kyle X. Hill, PhD, MPH, Universidad de Minnesota
- Seira Duncan, Candidata al PhD, Miembro del Comité Científico Internacional del Ártico

El presente manuscrito es un trabajo independiente de los autores con el apoyo y la contribución del equipo Connecting Climate Minds.

## Agradecimientos

Agradecemos el apoyo de los colegas que colaboraron en la realización de los diálogos: Erica Asinas (Tomadora de notas), Daniel Voskoboynik (Tomador de apuntes), Viviana Tipiani (Intérprete), Rebeka Ryvola de Kremer (Artista visual).

Kisani Upward apoyó el análisis de datos y la creación visual de este informe.

Seira Duncan apoyó el análisis de datos de este informe.

**Socios y coordinadores del diálogo intercomunitario:** Luis Romero Rengifo (Waman Wasi) and Kenneth Yongabi Anchang (Proyecto Ibanikom)

### Lista de Colaboradores:

Alan Rosen, Irma Lopez, Linda Sibiyá- Esawtini, Dina Juc, Vicente Gonzalez, Nomsa Simelane,

Donna Kerridge, Luis Romero, Girvan Tuanama, Michael Ridge, Beatriz Alida Balam Cocom, Richenel Ansano, Datu Lanelio Sangcoan, Emma Lee, Marta Yax, Mary Lee Jones, Rosa Elizabeth Flores Gómez, Krista Thie, Berta Miriam Maldonado Sabillón, Garin Riddle, Stewart Sutherland, Antonia Xuruc.

## Financiación

Este trabajo fue financiado por Wellcome.

## Conflictos de interés

Los autores no tienen conflictos de interés a declarar.

## Traducciones

Gracias a Climate Cardinals por las traducciones.



# Apéndice

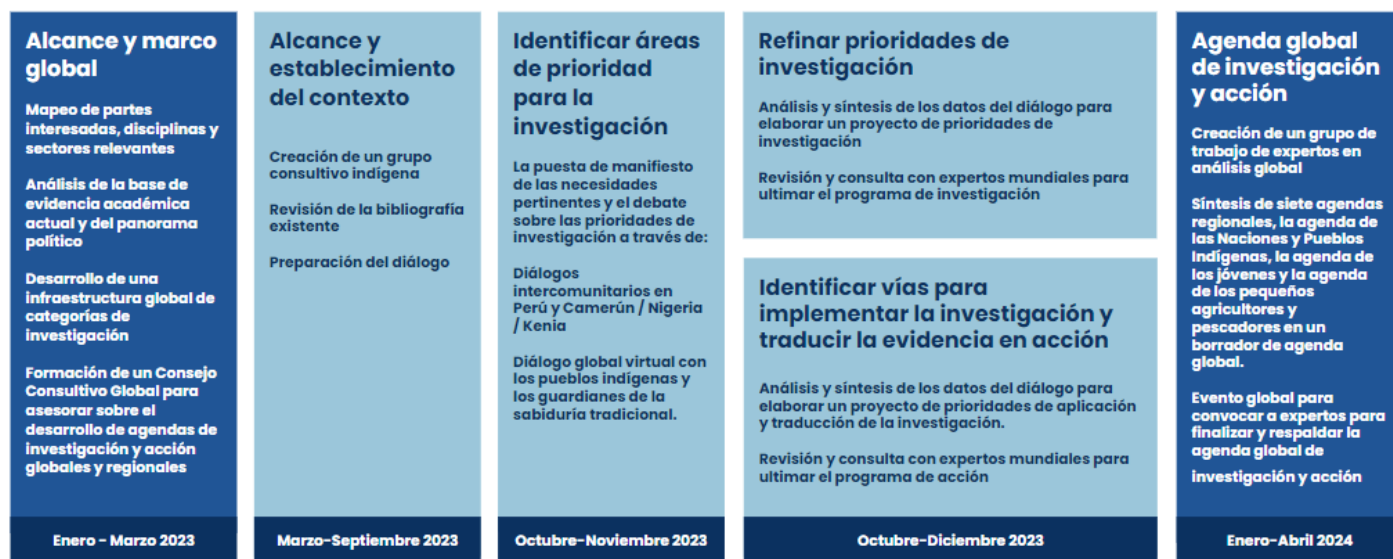
## Descripción General de CCM

Connecting Climate Minds (CCM) es un proyecto financiado por Wellcome que se puso en marcha en 2023 para desarrollar un programa inclusivo de investigación y acción en materia de cambio climático y salud mental. El proyecto tiene dos objetivos claves entrelazados. El primero es desarrollar una agenda inclusiva y alineada para la investigación y acción que esta basada en las necesidades de aquellos con experiencia vivida en relación con desafíos de salud mental en el contexto del cambio climático, para guiar el área dentro de los años siguientes. El segundo es dar el puntapié inicial para el desarrollo de las comunidades de practica por el cambio climático y la salud mental conectadas en siete regiones globales (designadas por los Objetivos de Desarrollo Sustentable), equipadas para representar esta agenda. Tenemos como objetivo el combinar las fortalezas de una perspectiva global y el foco regional, y reunimos diversas perspectivas disciplinarias en una visión común que pueda asegurar que la investigación es efectiva en abordar las brechas de evidencia prioritarias y al informar los cambios en políticas y practicas en la intersección del cambio climático y la salud mental.

## Métodos

Los métodos completos pueden consultarse [aquí](#).

La formulación de este programa fue el resultado de un esfuerzo de colaboración en el que participaron múltiples grupos diversos, entre ellos el equipo central de Connecting Climate Minds, el grupo Lived Experience Working Group, el grupo asesor indígena y nuestros socios de Diálogo intercomunitario. Además nos asociamos con la Cumbre Mundial de Jóvenes Indígenas sobre el Cambio Climático (Global Indigenous Youth Summit on Climate Change, GIYSCC) del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (United Nations Institute for Training and Research, UNITAR) para celebrar una sesión sobre nuestros diálogos indígenas. Los formatos y los métodos empleados en los diálogos indígenas fueron el resultado de la colaboración con nuestros socios y con el Grupo asesor indígena, que desempeñó un papel crucial en el desarrollo iterativo de la metodología, fomentando el intercambio de procesos, aprendizajes y retos entre las distintas regiones.



## Grupo Consultivo Indígena

Se contrató un grupo de seis asesores remunerados para ayudar a orientar la línea de trabajo del diálogo indígena. El reclutamiento para el Grupo Asesor consistió en la difusión a través de las redes existentes de CCM, contactos de los líderes regionales de diálogo y la red GIYSCC de UNITAR. La selección se basó en la disponibilidad, así como en el compromiso activo con las intersecciones entre el cambio climático y la salud de los indígenas. Entre los asesores indígenas hay investigadores indígenas, trabajadores sanitarios y jóvenes activistas de Estados Unidos, Singapur, Japón, Camerún y Australia. Los asesores indígenas aportaron sus comentarios sobre los procesos y marcos internos, orientaron las consideraciones éticas, facilitaron las conexiones para los diálogos y ofrecieron sus puntos de vista sobre el análisis de los datos.

## Metodología del diálogo

Los diálogos subtemáticos indígenas tuvieron lugar en 1) dos diálogos intercomunitarios y 2) un diálogo global en línea. La oportunidad de localizar el proceso de diálogo para las comunidades indígenas de distintas partes del mundo permitió que el proceso fuera dirigido por miembros y redes de confianza de las comunidades locales, que fueron contratados por el equipo del proyecto para dirigir los diálogos en persona. Los socios y miembros de la comunidad fijaron el programa de los encuentros y tuvieron la posibilidad de reescribir y adaptar las preguntas propuestas por el diálogo. Se celebró un diálogo intercomunitario

presencial de dos días de duración con las comunidades Kichwa de Alto Huaja, San Martín, Perú. Se celebró un diálogo intercomunitario en línea de dos horas de duración con miembros del reino Kom de la región noroccidental de Camerún, la diáspora Kom de Nigeria y a modo de intercambio, con miembros de la comunidad tribal Anam de Kenia.

Se celebró un diálogo virtual global de tres horas con los pueblos indígenas y los guardianes de la sabiduría tradicional con el objetivo de crear un proceso inclusivo que diera cabida a las diversas experiencias vividas y a la sabiduría de los participantes. Se utilizó una guía de facilitación semiestructurada que permitió que los temas emergentes surgieran de forma natural, con dos momentos de ruptura.

## Metodología del análisis

Los datos cualitativos de los diálogos fueron analizados por el equipo de investigación del CMHN, con el apoyo de dos miembros del Grupo Asesor Indígena. La codificación siguió un proceso de análisis temático que incluía la codificación deductiva según las categorías centrales de investigación de CCM, con ajustes de las categorías y los temas realizados inductivamente a partir de los datos del diálogo. Durante el proceso de codificación, se codificaron los temas y subtemas emergentes y se calculó la prevalencia de cada uno de ellos.

## Participantes

Los participantes en el diálogo eran un grupo diverso en cuanto a dispersión geográfica, género, sector y disciplina.

150 personas atendieron al taller de diálogo en persona de 2 días de diversas comunidades Kichwa, viajando desde 3 provincias en la región de San Martín del norte de Perú.

25 colaboradores, desde miembros de la comunidad en la villa Kom (Camerún), la comunidad Anam en Kenia y socios institucionales de la Universidad Claretiana de Nigeria y el Centro de Inculturación, Nairobi, Kenia, asistieron a un diálogo virtual.

Otros 36 participantes asistieron al diálogo virtual global.

Las tablas siguientes ofrecen un desglose de las características de los participantes para el dialogo global virtual.

### Distribución geográfica

|                           | Diálogo       |                   |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| <u>País</u>               | <u>Número</u> | <u>Porcentaje</u> |
| Australia                 | 5             | 14 %              |
| Curaçao                   | 1             | 2.9 %             |
| Esuatini                  | 3             | 8.6 %             |
| Finlandia                 | 1             | 2.9 %             |
| Guatemala                 | 3             | 8.6 %             |
| Honduras                  | 2             | 5.7 %             |
| Kenia                     | 1             | 2.9 %             |
| México                    | 2             | 5.7 %             |
| Nueva Zelanda             | 1             | 2.9 %             |
| Nicaragua                 | 1             | 2.9 %             |
| Nigeria                   | 1             | 2.9 %             |
| Panamá                    | 1             | 2.9 %             |
| Perú                      | 2             | 5.7 %             |
| Filipinas                 | 1             | 2.9 %             |
| Sudáfrica                 | 1             | 2.9 %             |
| Estados Unidos de América | 9             | 25.7 %            |

### Género

|               | Diálogo       |                   |
|---------------|---------------|-------------------|
| <u>Género</u> | <u>Número</u> | <u>Porcentaje</u> |
| Hombre        | 14            | 40 %              |
| Mujeres       | 19            | 54 %              |
| Otros         | 2             | 6 %               |

### Participantes de la encuesta pre-diálogo:<sup>1</sup> 37

<sup>1</sup>Tenga en cuenta que las cifras son aproximadas y no tienen en cuenta las respuestas duplicadas o incompletas.

## Ética, Recopilación y Almacenamiento de Datos

### Ética

Este estudio ha sido revisado y se le ha otorgado una opinión ética favorable por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad (Título del estudio: "Diálogos globales para establecer una agenda de investigación factible y construir una comunidad de practica en cambios climáticos y salud mental", numero de identificación del estudio: 6522690).

Este dialogo siguió los protocolos de ética alineados con el extenso proyecto CCM. Esto incluye un proceso de aprobación consensuada de la ICREC.

Guiándose por el movimiento de la Soberanía de Datos Indígenas (IDS)<sup>ii,2021</sup>, nos comprometemos a una conducción ética de la investigación que involucra a personas indígenas con una estructura para los diálogos que surgen de cuatro principios fundamentales: Respeto por las personas, preocupación por el bienestar, beneficio mutuo y transparencia. Los diálogos indígenas fueron basados en un enfoque orientado al proceso para investigar, donde en el proceso mismo es justamente tan importante así como el resultado final. En este proceso iterativo, centrado al rededor de la construcción de relaciones y la escucha activa, hemos puesto en practica varios mecanismos adicionales para respetar la autonomía y seguridad de miembros de la comunidad indígena, considerando potenciales impactos en su salud física, mental y espiritual, y circunstancias físicas económicas y sociales, siguiendo los principios de Titularidad, Control, Acceso y Protección (OCAP)<sup>22</sup>. Incluso estos: otorgar control a colaboradores indígenas sobre el diseño y custodia de los diálogos, enlazando con el Consejo de Revisión de Éticas del Colegio Imperial para asegurar la copropiedad de los datos con los colaboradores indígenas, proporcionando estipendios y compensaciones para todos los colaboradores, proporcionando mecanismos de calificación así como controles regulares para asegurar la responsabilidad y transparencia durante el proceso.

### Consentimiento informado

La conciencia cultural y la accesibilidad son consideraciones claves cuando se busca el consentimiento de comunidades e individuos indígenas. Estos procesos consideraron el

---

<sup>ii</sup>Puede encontrar la descripción del movimiento IDS aquí:  
<https://www.stateofopendata.od4d.net/chapters/issues/indigenous-data.html#fn:1>

lenguaje local y protocolos culturales determinados por las comunidades indígenas involucradas en las investigaciones. Después de consultar con nuestros asesores indígenas, nos involucramos en un proceso de dos etapas para obtener el consentimiento informado para los diálogos intercomunitarios en persona, envolviendo el consentimiento colectivo de autoridades tradicionales así como también el consentimiento individual de los participantes del dialogo. Buscamos el consentimiento individual para el dialogo virtual.

### **Recopilación, almacenamiento e intercambio de datos**

CCM reconoce el conocimiento de la propiedad de derechos intelectuales de las comunidades indígenas y solidifica la titularidad y control de datos de los indígenas. Consideramos imperativo garantizar el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas que pueda ser compartido en la diseminación de los descubrimientos de la investigación, de acuerdo con la Convención de la Organización Internacional del Trabajo 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los diálogos virtuales fueron conducidos en Zoom siguiendo el consentimiento informado de todos los participantes. Los datos de la investigación fueron colectados por CMHN y el Centro Climático de la Media Luna Roja de la Cruz Roja y luego transferidos a la Universidad Imperial de Londres para ser almacenados de forma segura en concordancia con las políticas de la Universidad Imperial usando un servidor seguro y la Ley de Protección de Datos RGPD 2018. Las comunidades Kichwa en San Martín, Perú y la Villa Kom en Camerún son los corresponsables por el tratamiento de los datos que los miembros de la comunidad proporcionaron a este estudio, y fueron responsables por reunir, almacenar y compartir estos datos con CMHN y la Universidad Imperial de Londres. Todos los datos relevantes fueron anonimizados y compartidos. El Imperial College de Londres conservará los datos durante 10 años tras la finalización del estudio.

### **Planteamiento de conceptos clave**

'El cambio climático', 'la salud mental' y sus intersecciones y términos relacionados, junto con otros conceptos clave relevantes son comprendidos y definidos de diversas maneras por la poblaciones indígenas. Identificar, reconocer y honrar las formas en que estos términos son comprendidos y utilizados en diferentes escenarios, es importante para ayudar a impulsar las conexiones, conciencia y reconocimiento a través de las disciplinas, culturas y comunidades.

Esta sección resalta los acuerdos relevantes entre los pueblos indígenas, diseñados para revelar la diversidad de perspectivas al rededor de los conceptos claves y otras discusiones durante el proyecto.

Participamos en conversaciones sobre la representación de los diálogos de los pueblos indígenas desde el comienzo de nuestro trabajo, incluyendo discusiones con asesores indígenas y socios de dialogo intercomunitarios. La necesidad de interrogar y ajustar el encuadre de la salud mental en esta serie particular de diálogos fue evidente desde el principio, ya que las perspectivas de los indígenas divergen del enfoque biomédico dominante que a menudo compartimentan la salud mental desde los ámbitos interconectados del bienestar social, cultural, territorial, espiritual y de la salud. Sin tal interrogación, el proyecto corre el riesgo de aumentar la eliminación y el daño a las visión del mundo de los indígenas.

Basado en estas conversaciones preliminares, los diálogos fueron enmarcados intencionalmente en formas – y usando vocabularios– que validan la visión del mundo de los indígenas y los acuerdos del cambio climático y la salud mental (tratados en la Introducción y en la sección aquí abajo). La invitación para el dialogo virtual es convergida al rededor de la siguiente pregunta: «Sanando nuestros cuerpos y territorios: *¿Como los cambios drásticos de salud de nuestras tierras afecta nuestra salud colectiva, espiritual y mental?*» La inclusión de la salud espiritual y colectiva en el marco del dialogo global virtual fue un esfuerzo intencional para reflejar los acuerdos de los cuerpos de salud y territorios, tal como fueron aconsejados por nuestros asesores y socios. Los socios de dialogo intercomunitarios dirigieron todas las conversaciones y estructuras en sus diálogos para asegurar la relevancia y el respeto por las visiones mundiales contextualizadas.

## Comprensiones de la salud mental

El término salud mental fue utilizado en todos los diálogos por los capacitadores y apareció en muchas de las preguntas realizadas. A pesar de esto, nuestros colaboradores casi siempre usaron otros marcos y/u otra terminología para responder preguntas planteadas y al compartir sus experiencias vividas. En particular, en el diálogo intercomunitario entre las comunidades Kichwa en la Amazonía del Perú, la “salud mental” no fue mencionada de forma alguna entre las respuestas de la comunidad. Al reconocer y valorar estas dimensiones interconectadas que sostienen algunas comunidades indígenas para lo que los paradigmas occidentales llaman salud y/o bienestar mental, podemos ir más allá de las limitaciones de

dichos marcos dominantes, fomentando enfoques culturalmente receptivos que se alineen con el rico tapiz de la sabiduría y conocimiento indígenas.

A continuación se muestra una selección de ideas que arrojan luz sobre el idioma y las interpretaciones que sustentan estos conceptos. Estas ideas pueden resumirse con la siguiente declaración hecha por uno de nuestros colaboradores: ***“Cuando nuestros espacios vitales son saludables, estamos bien”.***

### Terminología relevante

El vocabulario relacionado con los impactos en la salud mental favoreció las menciones de “estrés”, “desilusión”, “incertidumbre”, “duelo”, “ira” y “preocupación”. Por ejemplo, *“Estamos decepcionados. En este tiempo, todos estamos decepcionados”*. Emma Lee, del país de Tebrakunna, que aceptó ser nombrada, habló sobre la incongruencia de cierta terminología dominante de salud mental con la experiencia vivida por los indígenas: *“La incertidumbre es útil porque nos permite encajar entre nuestros Mayores, en nuestra comunidad. Pero la ansiedad es un constructo occidental. El idioma de la gestión, el de la crisis, no es el nuestro. Esa terminología de ansiedad necesita estar en una caja en algún lado. Distinción importante”*. Otros colaboradores señalan que *“se alzan nuevas enfermedades en las comunidades, tales como el estrés, la preocupación”, y “algunos han fallecido a causa del estrés”*.

Por lo tanto, los colaboradores comentaron sobre los peligros de no integrar los paradigmas indígenas en marcos de intervención e investigación: *“Dar energía por separado a la salud mental y al bienestar es un enfoque reduccionista introducido en la biomedicina que, sin darse cuenta, resta poder a las soluciones indígenas”*.

### Salud espiritual, colectiva y cultural

A menudo, las concepciones indígenas de la salud encapsulan una conexión emocional y espiritual con la tierra, haciendo énfasis en la ausencia de una dicotomía entre el sujeto y el objeto. Aunque diversas en su expresión cultural, estas perspectivas tienen sus bases en los profundos lazos entre la naturaleza y todos los seres, fomentando un entendimiento holístico de la interconexión entre humanos, su salud y bienestar, el medio ambiente y el reino espiritual. Se establecieron vínculos explícitos entre la salud cultural, espiritual, emocional y mental de manera consistente en las respuestas, tales como: *“Hay una clara conexión entre la salud*

*espiritual y cultural y, al tener un impacto negativo en estas prácticas importantes, también se ve impactada la salud mental (...) También hay salud espiritual, emocional y cultural”.*

Muchas enseñanzas de las comunidades Kichwa en la región del Amazonas hablan de la relación íntima con seres no humanos, donde la “desarmonía” fue origen tanto del malestar y la enfermedad, como de los eventos climáticos. Sentirse “mal” a menudo tiene que ver con eventos que involucran a las *ánimas* (espíritus) o es producto de su influencia. La apertura del mundo a la influencia de las *ánimas* (espíritus de los seres) que viven en el mundo, implica que una persona está expuesta a sufrir las consecuencias del “abandono” o la “huida”, de ser “*kutipado*” (poseído por un espíritu) o “amado” por ellos. Las dinámicas afectivas y relacionales oscilan de manera intermitente entre la armonía y la falta de la misma entre humanos y otros seres. Se utilizan remedios médicos y píldoras, pero sólo son considerados elementos complementarios a la curación tradicional que implica “prácticas, enfoques, conocimientos y creencias de salud que incorporan medicinas de origen vegetal, animal y mineral, terapias espirituales, técnicas y ejercicios manuales, aplicados singularmente o en forma conjunta para tratar, diagnosticar y prevenir enfermedades o mantener el bienestar”.<sup>23</sup>

### Relación entre la salud de la tierra y la salud humana

El vínculo inextricable entre la salud de la tierra (entendida como la salud de todos los seres del ecosistema compuesto por tierra, agua y los cielos) y la salud humana forma la esencia fundacional de la mayoría de las conceptualizaciones del bienestar indígena: *“Pienso en cómo se relaciona la salud física con la salud mental y está vinculado de forma intrínseca a la salud planetaria y cómo nosotros como personas indígenas cuidamos el 80 % de la biodiversidad en este planeta.”; «Necesitamos apoyo no sólo por la salud de las personas, sino para la salud de todo lo que existe.»*

De acuerdo con estas citas, un colaborador propuso la siguiente comprensión de un “enfoque triangular” para la curación ambiental, espiritual y física, unida por prácticas culturales: *“Tenemos nuestro enfoque triangular basado en nuestra sabiduría antigua. El primer enfoque, en la cima del triángulo, es sanar nuestra naturaleza, la Madre Tierra, la selva tropical. Proteger la naturaleza. El siguiente es continuar conservando nuestra conexión espiritual con la Madre Tierra así como parte de nuestra supervivencia. El tercero y último, nuestra sanación física. Por lo que, una vez que veamos que este enfoque triangular será implementado,*

*entonces podremos sobrevivir aquí. (...) La cultura es lo que los conecta.” (De un jefe indígena de Filipinas).*

### La tierra como líder

En la sabiduría indígena, la tierra no es sólo un espacio físico, sino una profunda sanadora, estrechamente vinculada a enfoques integrales de la salud. Al reconocer a la tierra como una fuente de poder sanativo, la comprensión indígena de la curación abarca una perspectiva holística que entrelaza el bienestar físico, mental y espiritual, enfatizando nuevamente la interconexión de la salud humana con la Tierra. En palabras de un colaborador: *“¿Cómo se verían nuestras comunidades si la sanación se basara en la tierra como sanadora?”*

Dada la profunda interdependencia con los demás seres, el mundo humano-emocional está lejos de estar encapsulado en lo que se considera la «mente», o lo «mental»; es decir, las experiencias humanas nunca están separadas de las redes más amplias de la vida de las que forman parte.

# Glosario

Descargue [aquí](#) un glosario que describe los conceptos relevantes y palabras clave para la investigación y agendas de acción de Connecting Climate Minds.

## Referencias

- 
- <sup>1</sup> Marting, M. F., & Zeitz, L. *Our lands, our minds: Research and action agenda on Indigenous mental health in a changing climate*. (Wellcome, 2024).
- <sup>2</sup> Bannister, K. Right Relationships: Legal and Ethical Context for Indigenous Peoples' Land Rights and Responsibilities. in *Plants, People, and Places* (ed. Turner, N. J.) 254–268 (McGill–Queen's Indigenous and Northern Studies, 2020).
- <sup>3</sup> Johnson, D., Parsons, M. & Fisher, K. Engaging Indigenous perspectives on health, wellbeing and climate change. A new research agenda for holistic climate action in Aotearoa and beyond. *Local Environ* **26**, 477–503 (2021).
- <sup>4</sup> Queensland Government. What Mental Health Means To Aboriginal And Torres Strait Islander Communities | Child Safety Practice Manual. *Queensland Government: Child Safety Practice Manual* <https://cspm.csyw.qld.gov.au/practice-kits/mental-health/working-with-aboriginal-and-torres-strait-islander/seeing-and-understanding/what-mental-health-means-to-aboriginal-and-torres> (2023).
- <sup>5</sup> RRC Polytech. Indigenous Health & Well-Being: Spirituality. *RRC Polytech Library and Academic Services* <https://library.rrc.ca/IndigenousHealth/Spirituality> (2023).
- <sup>6</sup> United Nations Department of Economic and Social Affairs. *State of the World's Indigenous Peoples*. (United Nations, 2021).
- <sup>7</sup> Vecchio, E. A., Dickson, M. & Zhang, Y. Indigenous mental health and climate change: A systematic literature review. *JCCH* **6**, 100121 (2022).
- <sup>8</sup> Gone, J. P. Redressing First Nations historical trauma: Theorizing mechanisms for indigenous culture as mental health treatment. *Transcult Psychiatry* **50**, 683–706 (2013).
- <sup>9</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) & Asia Pacific Forum (APF). *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Manual for National Human Rights Institutions*. 1–152 (OHCHR, APF, 2013).

- 
- <sup>10</sup> Ninomiya, M. E. M. *et al.* Indigenous communities and the mental health impacts of land dispossession related to industrial resource development: a systematic review. *Lancet Planet Health* **7**, e501–e517 (2023).
- <sup>11</sup> IPCC. *Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. 151 (IPCC, 2014).
- <sup>12</sup> Cunsolo Willox, A. *et al.* “From this place and of this place:” Climate change, sense of place, and health in Nunatsiavut, Canada. *Soc Sci Med* **75**, 538–547 (2012).
- <sup>13</sup> Cunsolo, A. & Ellis, N. R. Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss. *Nat Clim Change* **8**, 275–281 (2018).
- <sup>14</sup> Albrecht, G. *et al.* Solastalgia: The Distress Caused by Environmental Change. *Australas Psychiatry* **15**, S95–S98 (2007).
- <sup>15</sup> Brown, A. *et al.* Exploring the expression of depression and distress in aboriginal men in central Australia: a qualitative study. *BMC Psychiatry* **12**, (2012).
- <sup>16</sup> Gone, J. P. Redressing First Nations historical trauma: Theorizing mechanisms for indigenous culture as mental health treatment. *Transcult Psychiatry* **50**, 683–706 (2013).
- <sup>17</sup> Trzepacz, D., Guerin, B. & Thomas, J. Indigenous Country as a context for mental and physical health: Yarning with the Nukunu Community. *Australian Community Psychologist* **26**, (2014).
- <sup>18</sup> Stelkia, K. *et al.* Letsemot, “Togetherness”: Exploring How Connection to Land, Water, and Territory Influences Health and Wellness with First Nations Knowledge Keepers and Youth in the Fraser Salish Region of British Columbia. *IJIH* **16**, (2020).
- <sup>19</sup> Lancaster, R. Indigenous People Are Custodians Of Our Own Cultural Heritage. *SBS Voices* [www.sbs.com.au/voices/article/indigenous-people-are-custodians-of-our-own-cultural-heritage/at4c5sb21](http://www.sbs.com.au/voices/article/indigenous-people-are-custodians-of-our-own-cultural-heritage/at4c5sb21) (2020).
- <sup>20</sup> Smith, D. E. Governing data and data for governance: The everyday practice of Indigenous sovereignty. in *Indigenous Data Sovereignty* (eds. Kukutai, T. & Taylor, J.) 117–135 (ANU Press, 2016).
- <sup>21</sup> Kukutai, T. & Taylor, J. (2016). Data sovereignty for Indigenous peoples: Current practices and future needs. in *Indigenous Data Sovereignty* (eds. Kukutai, T. & Taylor, J.) 1–22 (ANU Press, 2016).
- <sup>22</sup> The First Nations Information Governance Centre. *Ownership, Control, Access and Possession (OCAP™): The Path to First Nations Information Governance*. (The First Nations Information Governance Centre, 2014).
- <sup>23</sup> Fokunang, C. *et al.* Traditional Medicine: Past, present and future research and development prospects and integration in the National Health System of Cameroon. *Afr J Trad Compl Alt Med* **8**, (2011).